

Consent Information – Patient Copy Drug Challenge Testing

معلومات الإقرار – نسخة المريض اختبار تحمل الدواء

1. What is a drug challenge test?

Recordings of routine baseline observations (blood pressure - BP, pulse - P and pulse oximetry - SpO2 etc) will be made. A cannula will then be inserted into a vein (intravenous cannula).

Diluted samples of the test drug will be prepared. The most dilute specimen will be injected first via an intravenous infusion into a vein (intravenously).

Providing no adverse reaction occurs to the test drug, samples of increasing concentration will be tested. Routine monitoring of observations (BP, P, SpO2 etc) will be observed and recorded.

Should there be no adverse response after a predetermined time (minimum of 30 minutes) then a less diluted sample of the drug will be infused intravenously. The development of any signs of 'anaphylaxis' will be regarded as a POSITIVE result. For example low BP (hypotension), wheezy chest (bronchospasm), swelling of the face and/or throat (oedema), a skin reaction (rash).

If signs develop, treatment with adrenaline and intravenous fluids will be given as required.

I understand that Direct Drug Challenge testing is not without risk, there is a chance of a severe reaction and indeed death.

I understand that I must NOT have anything to eat for 6 hours before this test, and I must NOT have anything to drink for 4 hours before this test. Also it is important that I do NOT consume alcohol in the 24 hours before the test

2. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

Specific risks:

- As with any drug reaction, the most severe risk is Death.
- Other severe risks:
- Low Blood pressure (Hypotension)
- Wheeze (Bronchospasm)
- Swelling of the face and throat (Oedema)
- Cardiac Arrest

3. What do I need to know about medication?

Some medications can interfere with testing. It is very important that you discuss any medications you are taking with the doctor beforehand. If it is possible you may need to stop some medications before the tests but this needs to be discussed with the doctor.

1. ما هو اختبار تحمل الدواء ؟

يتم تسجيل العلامات الاعتيادية المبدئية (ضغط الدم ، النبض و نسبة تشبع الدم بالأوكسجين ، الخ) . يتم بعد ذلك إدخال إبرة الخط الوريدي في الوريد. يتم تحضير عينات مخففة من دواء الاختبار. يتم حقن أكثر عينة تم تخفيفها (العينة الأقل تركيزاً للدواء) أولاً عبر مضخة وريدية إلى داخل الوريد. شريطة عدم ظهور تفاعلات عكسية لدواء الاختبار ، يتم اختبار عينات ذات تركيز متزايد . يتم مراقبة و تسجيل الملاحظات والعلامات الحيوية الاعتيادية (ضغط الدم ، النبض و نسبة تشبع الدم بالأوكسجين ، الخ).

إذا لم تحدث أي استجابة عكسية بعد مرور فترة زمنية محددة مسبقاً (30 دقيقة على الأقل) ، يتم ضخ عينة أقل تخفيفاً عبر الوريد.

يعتبر ظهور أي علامة للحساسية المفرطة نتيجة إيجابية ، مثل انخفاض الضغط ، صغير في الصدر (تشنج مجاري التنفس) ، تورم (استسقاء) الوجه وأو الحنجرة ، ردود فعل على الجلد (الطفح الجلدي). عند ظهور الأعراض ، يتم إعطاء العلاج بالـ (أدرينالين) والمحاليل الوريدية حسب الحاجة.

أنا على معرفة تامة بأن الاختبار المباشر لتحمل الدواء لا يخلو من المخاطر . هناك فرصة لحدوث رد فعل شديد وكذلك الوفاة.

إنني على دراية تامة بوجود عدم تناولي أي طعام خلال الـ 6 ساعات التي تسبق الاختبار ، كما أنه يتوجب علي عدم تناول أي مشروبات خلال الـ 4 ساعات التي تسبق الاختبار . كما أنه من الضروري عدم احتسائي الكحوليات خلال الـ 24 ساعة التي تسبق الاختبار.

2. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد ؟

هناك مخاطر و مضاعفات مرتبطة بهذا الاختبار و هي تشمل ، ولكنها غير محصورة في ما يلي:

مخاطر محددة:

- كما هو الحال مع أي تفاعل لأي دواء ، فإن الخطر الأكبر هو الوفاة.
- مخاطر أخرى شديدة:
- انخفاض ضغط الدم
- صغير في الصدر (تشنج مجاري التنفس)
- تورم الوجه و الحنجرة (استسقاء)
- السكتة القلبية

3. ما الذي ينبغي علي معرفته عن الدواء ؟

يمكن لبعض الأدوية أن تتداخل مع اختبار الدواء . من المهم جداً قيامك بمناقشة أي أدوية تتناولها حالياً مع طبيبك وذلك قبل خضوعك للاختبار. إذا كان ذلك ممكناً ، فقد تكون مضطراً للتوقف عن تناول بعض الأدوية التي تستخدمها قبل إجراء الاختبار ، إلا أن ذلك ينبغي مناقشته مع طبيبك المعالج.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Notes to talk to my doctor about:

أُمور أقوم بمناقشتها مع طبيبي:
